

1. **ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ** โครงการเปิดบ้านสร้างความเชื่อมั่น: นวัตกรรมการสื่อสารและบริการห้องผ่าตัดยุคใหม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2. **ผลงานประเภท** : การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement: CQI)

3. **คำสำคัญ** : ห้องผ่าตัดเด็ก, เทคโนโลยีการผ่าตัด, การทวนสอบตัวตนผู้ป่วย, ระบบติดตามสถานะเรียลไทม์, นวัตกรรมการสื่อสารศัลยกรรมเด็ก

4. **สรุปผลงานโดยย่อ** : โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการสื่อสารเชิงรุกเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กก่อนเข้ารับการผ่าตัด โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อวิดีโอแอนิเมชัน 3D ชุด "เปิดบ้านสร้างความเชื่อมั่น" ดำเนินเรื่องโดยคาแรกเตอร์ "พยาบาลห้องผ่าตัด" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และศักยภาพของห้องผ่าตัดเฉพาะทางเด็ก พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในขั้นตอนความปลอดภัยและการติดตามสถานะผ่าตัดแบบ Real-time ผลการดำเนินงาน พบว่าสามารถเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการจากร้อยละ 92.1 เป็นร้อยละ 96.2 โดยระดับคะแนนความวิตกกังวลของผู้ปกครองลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหลังได้รับชม และสามารถลดอัตราการเดินมาสอบถามข้อมูลซ้ำซ้อน หน้าประตูห้องผ่าตัดลงได้ถึงร้อยละ 80 ส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือในกระบวนการ รักษาพยาบาลอย่างสูงสุดเชิงระบบ

5. **เป้าหมายและวัตถุประสงค์** :

- เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้ปกครองได้รับข้อมูลขั้นตอนการเตรียมตัวและการปฏิบัติตัวในห้องผ่าตัดอย่างถูกต้อง 100%

- เพื่อลดระดับความวิตกกังวล และเพิ่มความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองต่อศักยภาพและเทคโนโลยี การผ่าตัดของสถาบันฯ ให้มากกว่า ร้อยละ 95

- เพื่อสื่อสารและเผยแพร่ศักยภาพของห้องผ่าตัดเฉพาะทางเด็ก ให้เป็นที่ประจักษ์และเข้าใจง่าย

6. **ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ** :

จากการทบทวนปัญหานี้พบว่ามีผู้ป่วยเด็กมีความวิตกกังวลสูงก่อนการผ่าตัด เนื่องจากขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการผ่าตัด ระบบความปลอดภัย และไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ห้องผ่าตัดได้ ส่งผลให้เกิดการสอบถามข้อมูลซ้ำหลายครั้ง รวมถึงการสื่อสารข้อมูลของบุคลากรยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

นอกจากนี้ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงศักยภาพ เทคโนโลยี และระบบติดตามสถานะการผ่าตัดของห้องผ่าตัดเฉพาะทางเด็ก จึงเกิดความไม่มั่นใจต่อกระบวนการรักษา

7. **กิจกรรมการพัฒนา** :

Plan – วิเคราะห์ปัญหาความวิตกกังวลของผู้ปกครองและปัญหาการสื่อสารข้อมูลก่อนผ่าตัดจากการทบทวนปัญหานี้

Do - พัฒนาสื่อวิดีโอแอนิเมชัน 3D เรื่อง “เปิดบ้านสร้างความเชื่อมั่น” ประกอบด้วย

ขั้นที่ 1: จัดหมวดหมู่และรวบรวมศักยภาพห้องผ่าตัด (Knowledge Capture): ทำการรวบรวมข้อมูลเฉพาะของห้องผ่าตัดเพื่อสร้างความมั่นใจในความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ห้องผ่าตัด 1-2 (ศัลยกรรมจักษุ), ห้องผ่าตัด 3 (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ), ห้องผ่าตัด 4 (ศัลยกรรมหู คอ จมูก), ห้องผ่าตัด 5 (การส่องกล้องระบบทางเดิน หายใจ/อาหาร), ห้องผ่าตัด 6 (การผ่าตัดแผลเล็ก: MIS), ห้องผ่าตัด 7 (ศัลยกรรมทั่วไป), ห้องผ่าตัด 8 (ศัลยกรรม ระบบทางเดินปัสสาวะ/ทกแต่ง), ห้องผ่าตัด 9 (ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท) และห้องผ่าตัด 10 (ศัลยกรรม หัวใจและหลอดเลือด)

ขั้นที่ 2: ผลิตนวัตกรรมสื่อ "อุ่นใจทุกก้าวเดิน" (Media Production): ผลิตวิดีโอสั้นในรูปแบบแอนิเมชัน 3D (Pixar Style) เพื่อลดความกลัวทางการแพทย์ โดยเรียงลำดับเนื้อหาผ่าน 4 จุดสำคัญ:

1. Welcome: แนะนำตัวละครพยาบาลเพื่อสร้างความคุ้นเคย
2. Verification: สอนขั้นตอนการตรวจสอบชื่อ-นามสกุล, เลข HN, โรค และตำแหน่งผ่าตัดอย่างมีส่วนร่วม
3. OR Tour: พาทัวร์นวัตกรรมและเครื่องมือล้ำสมัยในห้องผ่าตัด
4. Post-Op & Tracking: แนะนำระบบจอ Monitor ติดตามสถานะในห้องผ่าตัด และการดูแลอย่างใกล้ชิดในห้องพักฟื้น (Recovery Room)

ขั้นที่ 3: ออกแบบช่องทางการสื่อสารอย่างไร้รอยต่อ (Omni-channel Deployment): เปิดสู่นวัตกรรมดังกล่าวผ่านระบบจอดิจิทัล บริเวณพื้นที่นั่งรอหน้าห้องผ่าตัดอย่างต่อเนื่องเชิงรุก

Check – ประเมินผลเชิงเปรียบเทียบระดับความวิตกกังวลก่อน-หลังรับชมวิดีโอ ประเมินร้อยละความพึงพอใจต่อการได้รับข้อมูลข่าวสาร และติดตามสถิติจำนวนครั้งของการเดินมาสอบถามเข้าห้องผ่าตัดเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลจริงของนวัตกรรม

Act - นำผลประเมินและคำสะท้อนคิดมาปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้รับบริการยิ่งขึ้น พร้อมเตรียมแผนพัฒนาคลิปวิดีโอย่อยเฉพาะสาขาศัลยกรรม (Sub-specialty) เพื่ออัปเดตเทคโนโลยีในอนาคต

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ :

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองและผู้รับบริการต่อการได้รับข้อมูลมากกว่าร้อยละ 95
- ระดับความวิตกกังวลของผู้ปกครองลดลงหลังได้รับชมสื่ออย่างมีนัยสำคัญ
- จำนวนการสอบถามข้อมูลเข้าห้องผ่าตัดลดลง
- ร้อยละของบุคลากรที่สามารถสื่อสารข้อมูลได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ร้อยละ 100

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ : (ระยะเวลาดำเนินการ 10 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 69)

การประเมินผล	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ (หลังใช้นวัตกรรม)
1. ด้านความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้	คะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดจากเดิม ร้อยละ 92.1 ขยับขึ้นเป็นร้อยละ 96.2
2. ด้านจิตวิทยาและการลดความกังวล	ระดับความวิตกกังวลของผู้ปกครองลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	• ระดับคะแนนความวิตกกังวลลดลงอย่างมีนัยสำคัญ • ผู้ปกครองเข้าใจขั้นตอนและให้ความร่วมมือในกระบวนการทวนสอบตัวตน (Patient Verification)

3. ด้านประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อน	ลดอัตราการสอบถามข้อมูลซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	• ลดจำนวนครั้งในการเดินมาสอบถามสถานะลดลงกว่า 80% • ผู้ปกครองติดตามสถานะได้เองผ่าน Tracking System
4. การเข้าถึงสื่อเชิงรุก	ความครอบคลุมในการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายหน้างาน	สถิติบันทึกพบผู้รับบริการนั่งจ่อรับชมวิดีโอ มากกว่า 100 ครั้ง ภายใน 1 เดือน



10. บทเรียนที่ได้รับ :

ความท้าทายด้านความแปรปรวนในการเข้าถึงสื่อ (Variability of Patient Engagement):

ปัญหาที่พบใน Cycle แรก: แม้จะมีการติดตั้งจุดดิจิทัลเปิดวนซ้ำหน้าห้องผ่าตัด (Omni-channel) และมีสถิติการรับชมมากกว่า 100 ครั้งใน 1 เดือน แต่พบว่า "ระดับความตั้งใจและโอกาสในการรับชม" ของผู้ปกครองแต่ละรายยังไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับเวลาที่มาถึงหน้าห้องผ่าตัด และภาวะวิกฤตทางอารมณ์ในขณะนั้น

แนวทางระบบที่ต้องเดินต่อ: การเปิดฉายหน้าห้องผ่าตัดอย่างเดียวยังอาจไม่พอ (Passive) ในอนาคตจำเป็นต้องขยายผลเชิงรุก (Active) เช่น ส่งลิงก์วิดีโอผ่าน Line ให้ผู้ปกครองได้เปิดดูพร้อมกับบุคลากรตั้งแต่ที่ตึกผู้ป่วยใน (IPD) หรือตั้งแต่ที่บ้านก่อนมาโรงพยาบาล (Pre-admission) เพื่อลดความแปรปรวนในการรับรู้ข้อมูล

ความท้าทายด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง (Dynamic Technology Integration):

ปัญหาที่พบใน Cycle แรก: วิดีโอแอนิเมชันใน Cycle แรก เป็นการรวบรวมศักยภาพภาพรวมของห้องผ่าตัด แต่เนื่องจากสถาบันฯ มีการนำเข้าเครื่องมือระดับสูงและเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ (เช่น ระบบ Navigator หรือ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในอนาคต)

แนวทางระบบที่ต้องเดินต่อ: สื่อที่มีอยู่จำเป็นต้องได้รับการอัปเดตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และในอนาคตต้องวางระบบจัดทำคลิปปริทัศน์ย่อยเฉพาะสาขาศัลยกรรม (Sub-specialty) เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัยและตอบสนองต่อทิศทางการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence)

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน :

ชื่อ - นามสกุล นางสาวไพลิน พึ่งทอง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

หน่วยงาน การพยาบาลผ่าตัดผู้ป่วยใน เบอร์โทรศัพท์ 082-209-9441 E-mail :35143@chs.ac.th

ภาพตัวอย่างวิดีโอ โครงการเปิดบ้านสร้างความเชื่อมั่น
นวัตกรรมการสื่อสารและบริการห้องผ่าตัดยุคใหม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

